

Surveillance épidémiologique du rotavirus

2025

Auteur C. Dambre¹

Révision L. Cuypers² • J. Matthijnsens² • P. Carrillo³ • H. Theeten⁴ • N. Hammami⁴

¹Epidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano; ²Centre national de référence rotavirus, UZ/KU Leuven; ³Fédération Wallonie-Bruxelles; ⁴Département Zorg.

Messages clés

Forte augmentation des cas rapportés en 2025

D'après les données des laboratoires vigies, 5092 cas ont été rapportés en 2025, une augmentation de 75% par rapport à 2024 et le nombre le plus élevé depuis l'introduction de la vaccination.

Augmentation observée principalement chez les personnes plus âgées

Même si l'augmentation s'est produite dans la plupart des groupes d'âge, elle a été plus marquée chez les personnes âgées. Un décuplement du nombre de cas a été observé chez les personnes de 80 ans et plus.

Augmentation due en grande partie à des changements dans le diagnostic

Le passage à des tests PCR multiplex a eu pour résultat une plus grande détection et davantage de diagnostics. Une augmentation réelle de la circulation du virus n'est toutefois pas à exclure.

Le génotype G2P[4] à nouveau dominant en 2025

Après une domination totale du génotype G3P[8] en Belgique pendant quelques années, une diminution de ce génotype a été observée en 2025, alors que le génotype G2P[4] gagnait de nouveau en fréquence.

Vaccination recommandée pour tous les nourrissons

Le rotavirus reste une cause importante de gastro-entérite. Ce virus est très contagieux et peut entraîner une hospitalisation, surtout chez les jeunes enfants. Le Conseil supérieur de la Santé recommande donc la vaccination pour tous les nourrissons.

Table des matières

1. Description de la surveillance	4
1.1. Sources de données.....	4
1.1.1. Définition de cas	4
1.1.2. Représentativité des données	4
2. Résultats	5
2.1. Résultats des laboratoires vigies.....	5
2.1.1. Tendances par année.....	5
2.1.2. Tendances par groupe d'âge.....	6
2.1.3. Tendances par région.....	7
2.1.4. Tendances dans l'utilisation de tests diagnostiques	7
2.2. Courbe saisonnière.....	9
2.3. Distribution des génotypes	10
2.4. Hospitalisations et mortalité.....	11
2.4.1. Hospitalisations.....	11
2.4.2. Mortalité	11
3. Importance pour la santé publique.....	12
Plus d'informations	13
Références	13

1. Description de la surveillance

La surveillance du rotavirus en Belgique repose sur les données provenant de différentes sources, qui sont discutées d'une manière intégrée dans le présent rapport.

1.1. Sources de données

- **Réseau de laboratoires vigies (Epilabo)** : un réseau qui, sur une base volontaire, rapporte des données diagnostiques à Sciensano. Les cas de rotavirus sont enregistrés depuis 1999. La surveillance a été interrompue entre 2002 et 2004.
- **Le Centre national de référence (CNR) pour le rotavirus (UZ/KU Leuven)** : assure la surveillance moléculaire des types de rotavirus en circulation via le génotypage. Le CNR analyse un sous-groupe de souches envoyées par les laboratoires sur une base volontaire.
- **Résumé hospitalier minimum (RHM)** : tous les hôpitaux non psychiatriques de Belgique sont tenus de contribuer à l'enregistrement anonymisé de données administratives, médicales et infirmières relatives à toutes les hospitalisations. Les maladies sont codées depuis 2016 selon l'«*International Classification of Diseases*», 10e version (ICD-10). Les données sont disponibles avec un retard de deux ans.
- **Données de mortalité** : collectées au travers des certificats de décès, enregistrées par les Communautés flamande et française et centralisées par Statbel. Depuis 1998, l'«*International Classification of Diseases* », 10e version (ICD-10) est utilisée pour coder les causes de décès. Les données sont disponibles avec un retard de trois ans.

1.1.1. Définition de cas

Une infection à rotavirus confirmée est définie comme suit par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : «l'isolement de rotavirus ou la détection de l'acide nucléique ou de l'antigène de rotavirus dans les selles». Cette définition de cas est suivie par les laboratoires vigies et par le CNR. Pour le RHM, nous nous basons sur les séjours à l'hôpital avec pour diagnostic principal le code ICD10-A080 (rotavirus enteritis), qui est également utilisé pour le codage des données de mortalité.

1.1.2. Représentativité des données

Aucune de ces sources de données n'est exhaustive et elles ne permettent donc pas d'estimer le nombre absolu de nouveaux cas en Belgique. Elles permettent par contre de suivre des tendances.

Le système de surveillance Epilabo repose sur la participation volontaire des laboratoires. La couverture a été estimée au cours des dernières années sur la base des données de remboursement de l'INAMI pour les tests du rotavirus chez les enfants de moins de 2 ans (rapport entre les tests effectués par les laboratoires participants et le total national) et s'élevait à 43% en 2023. En raison de l'utilisation plus étendue de panels gastro-intestinaux par PCR multiplex, qui ne sont actuellement pas remboursés, cette approche n'est plus applicable. C'est la raison pour laquelle la représentativité du réseau n'est évaluée cette année que sur la base du nombre de laboratoires participants et de leur répartition géographique. Au total, 47 laboratoires ont rapporté au moins 1 cas en 2025, dont 34 en Flandre, 4 à Bruxelles et 9 en Wallonie. Cette répartition a été stable sur les 5 dernières années, avec une sous-représentativité connue et persistante en Bruxelles et surtout en Wallonie.

Le Résumé Hospitalier Minimum ne présente pas cette variation géographique étant donné que tous les hôpitaux belges sont obligés d'y participer. Il faut toutefois tenir compte de quelques limitations: ces données n'étaient au départ pas collectées à des fins épidémiologiques et le diagnostic et la codification des maladies peuvent varier d'un hôpital à l'autre.

2. Résultats

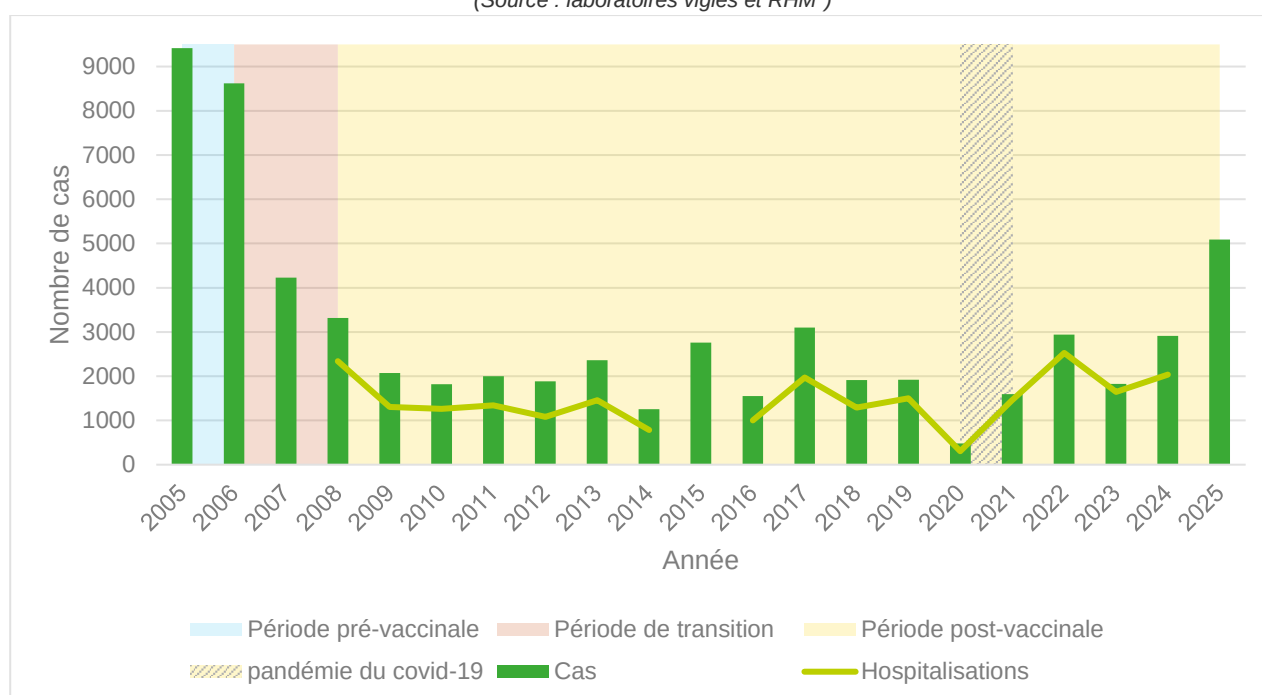
2.1. Résultats des laboratoires vigies

2.1.1. Tendances par année

Le nombre annuel de cas rapportés d'infection à rotavirus et d'hospitalisations est représenté dans la Figure 1. Une période pré-vaccinale (jusque juin 2006), une période dite «de transition» durant laquelle les vaccins ont été introduits (juillet 2006 – juin 2008) et une période post-vaccinale (à partir de juillet 2008) y sont différenciées. Depuis la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé de vacciner les nourrissons contre le rotavirus et le remboursement partiel en 2006, le nombre de cas confirmés d'infection à rotavirus a considérablement diminué par rapport à la période pré-vaccinale.

En 2025, une forte augmentation des cas a été rapportée au sein des laboratoires vigies, avec 5092 infections à rotavirus. C'est une hausse de 75% par rapport à 2024 (n=2912) et le nombre le plus élevé de cas rapportés depuis l'introduction de la vaccination. Le nombre d'hospitalisations pour 2025 n'était pas encore disponible au moment de rédiger le présent rapport.

Figure 1: Nombre de cas confirmés d'infection à rotavirus et nombre d'hospitalisations rapportées par an, 2005-2025, Belgique
(Source : laboratoires vigies et RHM*)



*Le Résumé hospitalier minimum n'est pas disponible pour 2015 en raison du changement de code de ICD-9 en ICD-10.

2.1.2. Tendances par groupe d'âge

Chez les enfants de moins de cinq ans, l'augmentation de 2025 a été observée dans tous les groupes d'âge comprises entre 0 et 11 mois. Au total, chez ces enfants de moins d'un an (n=1930), on a constaté presque un doublement du nombre de cas qui a été observé par rapport à 2024. Chez les enfants de 12 à 59 mois, le nombre de cas a diminué de 37.5% (810 en 2025 par rapport à 1297 en 2024) (Figure 2).

Chez les patients âgés de plus de 5 ans, une augmentation relative du nombre de cas a été observée, augmentant avec l'âge (Figure 3). Chez les 5-19 ans (n = 297) et les adultes de 20 à 39 ans (n = 199), on a constaté un doublement du nombre de cas par rapport à 2024. Dans les groupes d'âge de 40-59 ans et de 60-79 ans, les augmentations étaient encore plus marquées, avec respectivement 210 cas (+218%) et 559 cas (+326%).

L'augmentation la plus frappante a toutefois été observée chez les personnes de 80 ans et plus. Dans ce groupe, le nombre de cas fluctuait entre 25 et 170 au cours des dernières années, avec une exception en 2022 (n=426). En 2025, ce nombre est passé à pas moins de 1102 cas (Figure 3).

Figure 2: Nombre d'infections à rotavirus rapportées chez les enfants de moins de 5 ans, par groupe d'âge, par an, 2019-2025
(Source : laboratoires vigies)

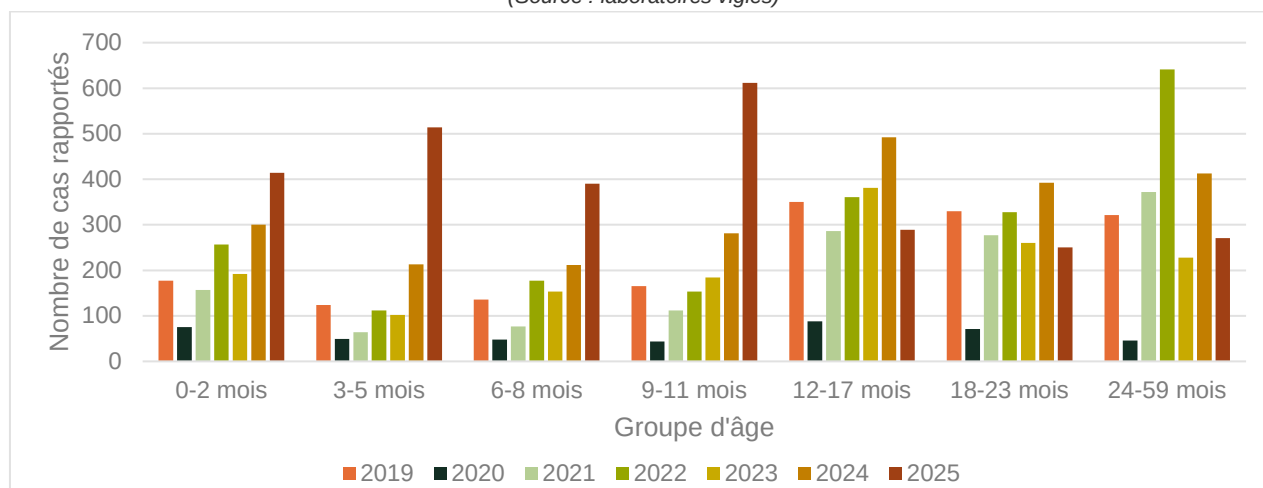
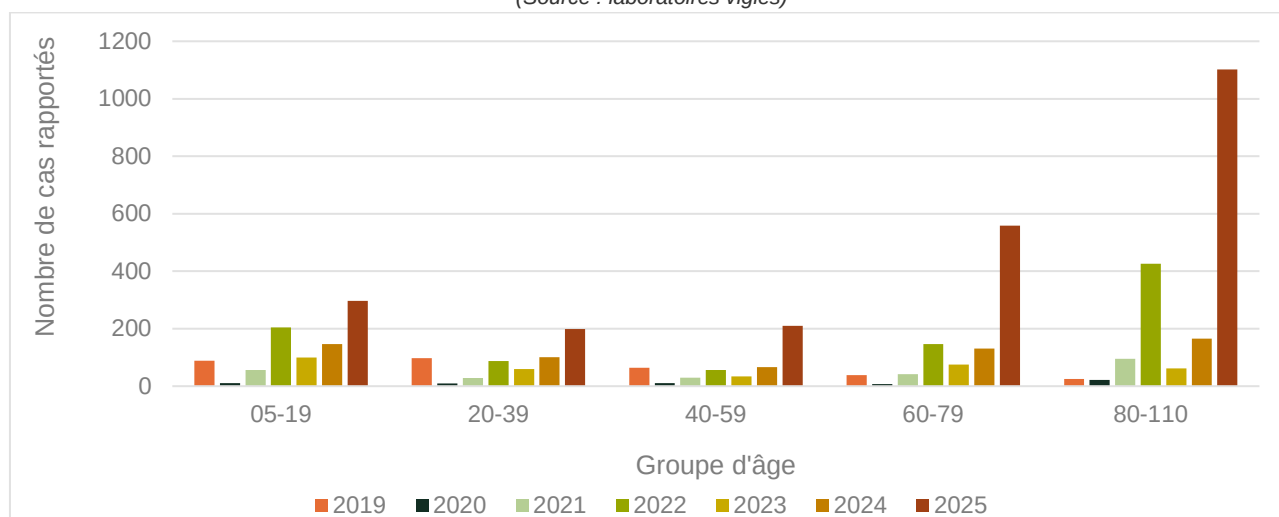


Figure 3: Nombre d'infections à rotavirus rapportées 5-110 ans, par groupe d'âge, par an, 2019-2025
(Source : laboratoires vigies)

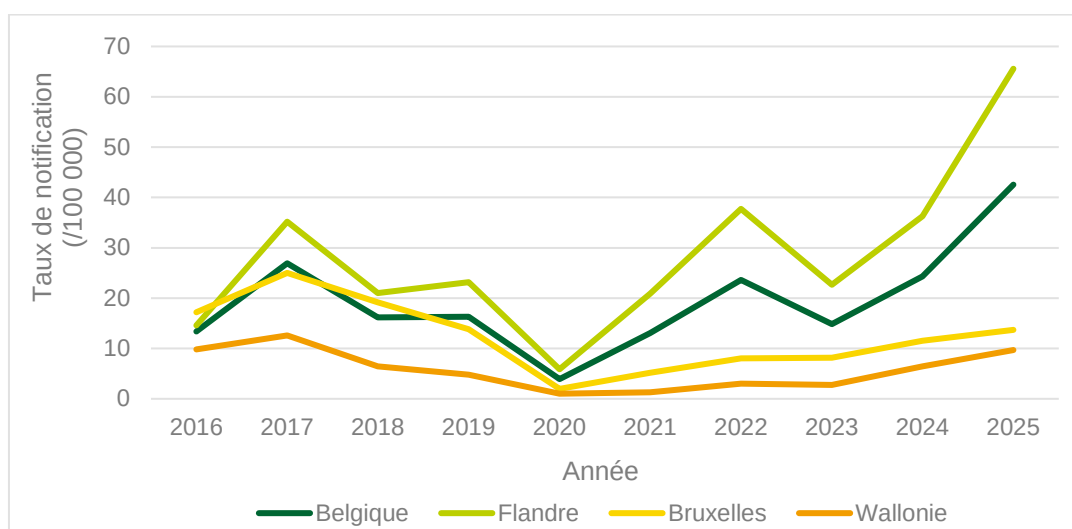


2.1.3. Tendances par région

Le nombre de cas confirmés en 2025 était de 42.5 pour 100.000 habitants pour l'ensemble de la Belgique. Dans toutes les régions, une augmentation a été constatée par rapport à 2024 (Figure 4). Elle était toutefois étonnamment plus marquée en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. La Flandre a connu l'incidence rapportée la plus élevée: 65.6 pour 100.000 habitants (n=4501). Cette forte augmentation en Flandre est observée dans toutes les provinces flamandes, mais c'est principalement dans les provinces de Flandre orientale et occidentale que des nombres particulièrement élevés ont été rapportés : 139 pour 100 000 et 66 pour 100 000 habitants respectivement (41-46 pour 100 000 dans les autres provinces flamandes).

Dans la région de Bruxelles-Capitale, l'incidence rapportée a augmenté pour atteindre 13.7 pour 100.000 habitants (n=172). En Wallonie enfin, celle-ci était de 9.7 pour 100.000 habitants (n=358).

Figure 4: Incidence rapportée d'infections à rotavirus (nombre de cas confirmés pour 100 000 habitants), par région, 2016-2025
(Source : laboratoires vigies)



En raison d'un sous-rapportage connu au sein du réseau des laboratoires vigies en Bruxelles et en Wallonie, la charge réelle de la maladie est sous-estimée dans cette région. Des comparaisons entre régions sur la base de ces données sont de ce fait difficiles à interpréter. Il est donc préférable d'analyser séparément les tendances au sein de chaque région, plutôt que de comparer les régions entre elles.

2.1.4. Tendances dans l'utilisation de tests diagnostiques

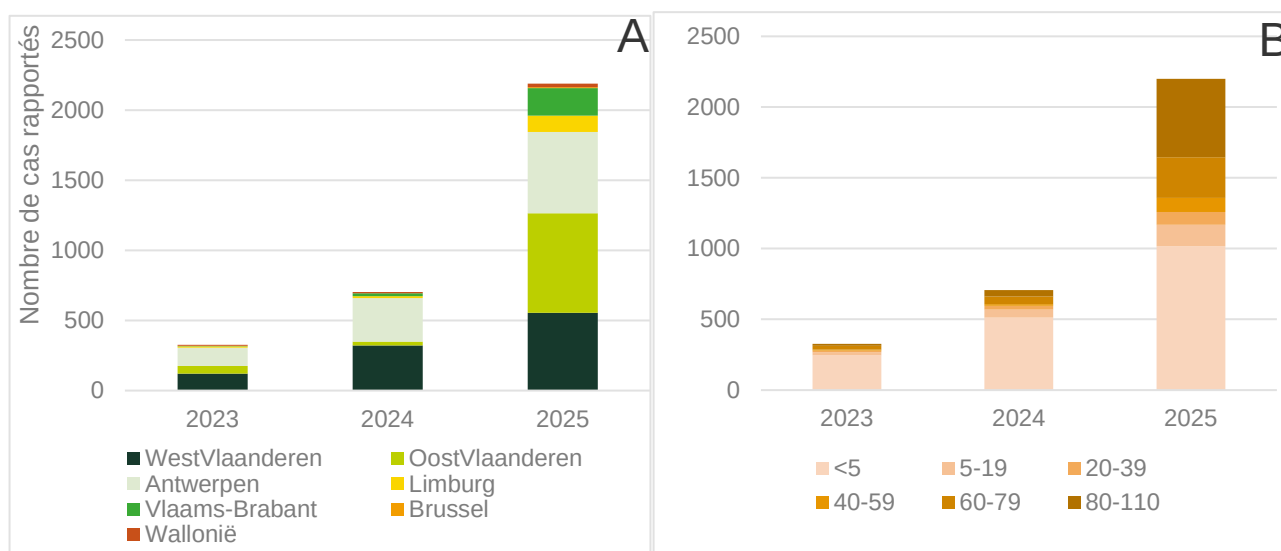
Une tendance frappante en 2025 est la forte augmentation du nombre de cas de rotavirus détectés via PCR (Tableau 1). Cette augmentation contraste avec les années précédentes, au cours desquelles les tests antigéniques étaient la méthode diagnostique dominante. Cette augmentation va principalement de pair avec l'introduction et l'utilisation croissante de panels gastro-intestinaux par PCR multiplex dans les hôpitaux.

Tableau 1: Méthode de test utilisée pour le diagnostic des infections à rotavirus, 2019-2025, Belgique
(Source : laboratoires vigies)

Année	Antigène	Culture	Microscopie	PCR	PCR/Total	Sérologie	Autre	Inconnu	Total
2019	1480	4	19	68	4 %	1	20	327	1919
2020	344	3	0	30	6 %	1	13	93	484
2021	1167	3	0	131	8 %	0	52	242	1595
2022	2268	9	1	87	3 %	1	101	472	2939
2023	1149	15	5	326	18 %	2	46	284	1827
2024	1269	26	0	706	24 %	0	1	910	2912
2025	1529	32	3	2198	43 %	4	41	1285	5092

Une analyse de l'augmentation du nombre de tests PCR montre que celle-ci s'est principalement produite en Flandre (Figure 5A). Une augmentation a été constatée dans toutes les provinces flamandes, avec l'augmentation la plus marquée en Flandre orientale. Dans les provinces wallonnes et à Bruxelles, seulement peu de cas de rotavirus ont en revanche été diagnostiqués via PCR (25 en Wallonie et 7 à Bruxelles en 2025, contre 2157 en Flandre en 2025). Si on considère les catégories d'âge, on observe également une augmentation évidente des diagnostics PCR dans tous les groupes. L'augmentation en pourcentage est la plus élevée dans le groupe d'âge le plus âgé, où le nombre de tests PCR était plus de dix fois plus élevé en 2025 qu'en 2024 (Figure 5B).

Figure 5: Nombre d'infections à rotavirus diagnostiquées via PCR, par province (A) et par groupe d'âge (B), 2023-2025
(Source : laboratoires vigies)



Ces résultats suggèrent que l'augmentation du nombre de tests PCR est fortement associée à l'augmentation du nombre de cas rapportés en 2025, à savoir chez les personnes âgées et en Flandre.

Toutefois, si nous excluons tous les PCR et les inconnus, nous observons en Belgique une augmentation de cas de 25% par rapport à l'année précédente, totalement marquée par une augmentation en Flandre, alors que les cas à Bruxelles et en Wallonie restaient stables ou diminuaient. Cela indique qu'une augmentation réelle dans la circulation du virus a aussi potentiellement contribué à l'augmentation de 2025.

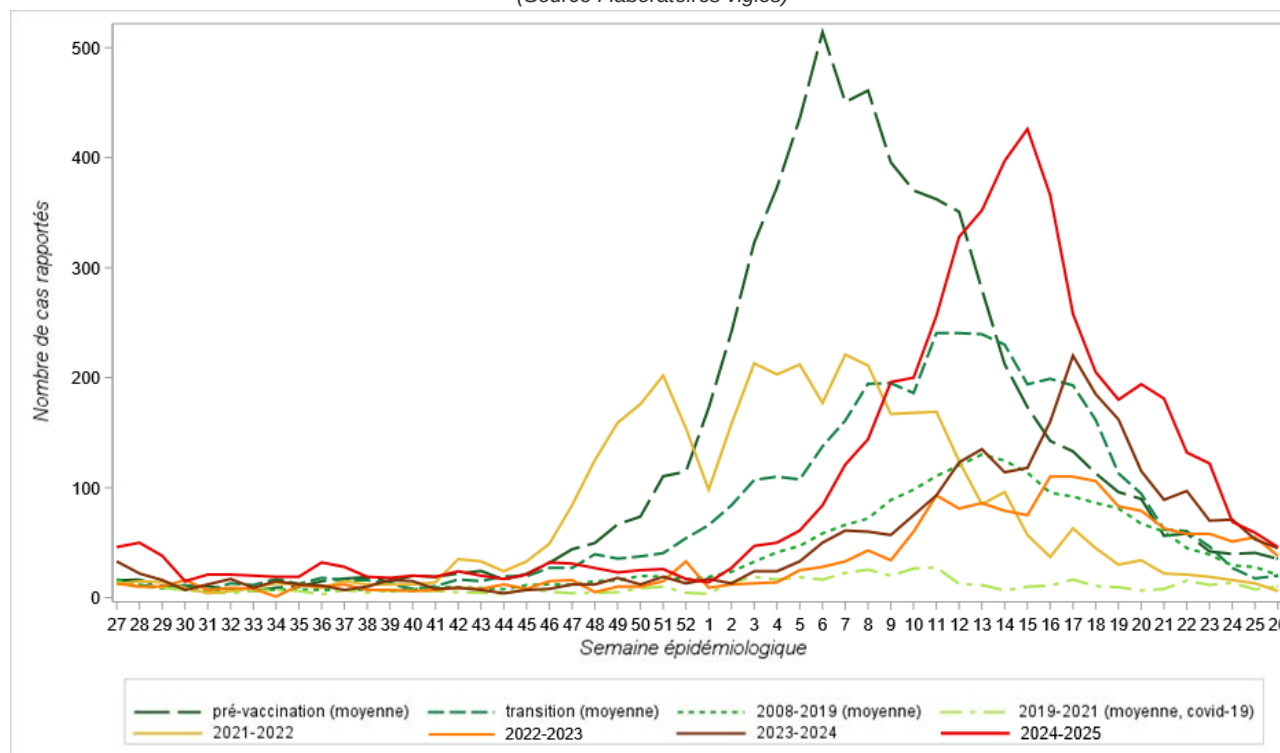
2.2. Courbe saisonnière

Les infections à rotavirus présentent un schéma saisonnier clair, avec chaque année un pic épidémique pendant l'hiver (Figure 6). En 2025, la saison du rotavirus¹ a commencé en février (semaine 7) et a duré 18 semaines, avec un pic en avril lorsque 467 cas ont été enregistrés au cours de la semaine 15. C'est le pic le plus élevé depuis la période pré-vaccinale. Le timing de cette saison était comparable à celui de 2023, avec un pic en avril mais avec un nombre beaucoup moins élevé de cas (220 au cours de la semaine 17).

L'introduction de la vaccination contre le rotavirus a fortement influencé les courbes saisonnières. Non seulement, l'intensité du pic a diminué mais le timing a également reculé. Pendant la période pré-vaccinale, le pic était généralement observé autour de la semaine 6 alors qu'en période post-vaccinale, ce pic reculait à la semaine 13. De plus, les saisons étaient généralement plus courtes après la vaccination.

Cette tendance a été interrompue pendant la pandémie du COVID-19, lorsque très peu de cas ont été rapportés et qu'il a été à peine question d'une saison classique pour le rotavirus. La saison suivante (2021-2022) s'est déroulée d'une manière atypique, avec un début précoce et un premier pic déjà observé au cours de la semaine 51 de 2021, suivi d'une large répartition sur les mois d'hiver. Au cours des saisons suivantes, le pic a de nouveau reculé à des dates ultérieures (environ la semaine 16) et la saison s'est terminée plus tard qu'à l'ordinaire pendant la période post-vaccinale. La saison 2024-2025 suit également ce schéma post-COVID.

Figure 6: Nombre moyen de cas de rotavirus rapportés par semaine pendant la période pré-vaccinale (1999-2006), pendant la période transitoire (2006-2008), pendant la période post-vaccinale (2008-2019), pendant la période COVID-19 (2019-2021) et les quatre dernières saisons en Belgique
(Source : laboratoires vigies)



¹ Le début de la saison du rotavirus est défini par l'OMS comme la semaine au cours de laquelle le nombre de cas dépasse pour la première fois le nombre moyen de cas par semaine pour toute l'année. (1)

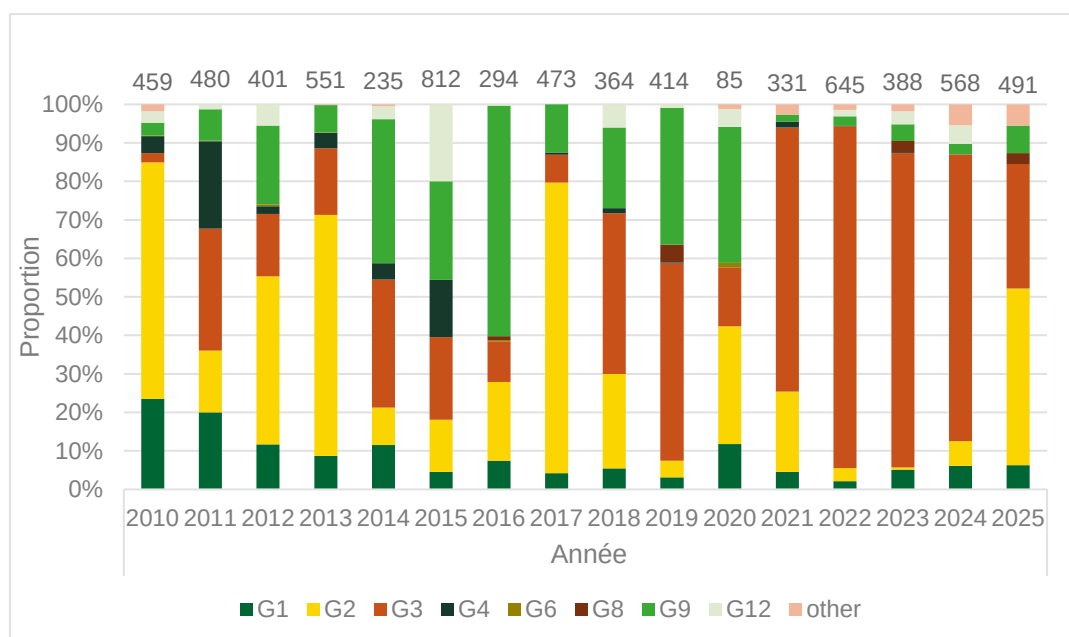
2.3. Distribution des génotypes

Les génotypes G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] et G9P[8] sont dominants en Europe toutes années confondues. La distribution des génotypes circulants varie toutefois d'une année à l'autre et une co-circulation de plusieurs souches s'observe chaque année (Figure 7). Le CNR se charge du génotypage des rotavirus en Belgique.

En 2025, un changement clair dans la distribution des génotypes a été constaté et la proportion du G3P[8], qui était le génotype dominant au cours des dernières années, a de nouveau diminué. Ce type était responsable de 31% des cas génotypés, alors que le G2P[4] et le G2P[8] augmentaient en fréquence et représentaient ensemble 46% des cas.

Depuis la saison rotavirus 2021-2022 atypique, le génotype G3P[8] dominait largement. Des analyses du CNR montrent qu'il s'agit principalement du variant G3P[8] 'equine-like' (de type équin), qui a été découvert pour la première fois en Belgique en 2014 et qui depuis, a remplacé un peu à la fois le variant G3P[8] humain (2). La cause de cette dominance exceptionnelle n'est pas entièrement connue mais est probablement influencée par une variation naturelle et par un goulet d'étranglement dans les génotypes en circulation en raison des confinements pendant la pandémie du COVID-19. Une efficacité amoindrie du Rotarix® contre ce génotype a été suggérée mais l'évidence est limitée et n'est pas claire. La redistribution des génotypes en 2025, sans modification dans la politique de vaccination, semble davantage indiquer une variation naturelle.

Figure 7: Distribution des génotypes de rotavirus en circulation par année, 2010-2025
(Source: CNR (UZ/KU Leuven))



2.4. Hospitalisations et mortalité

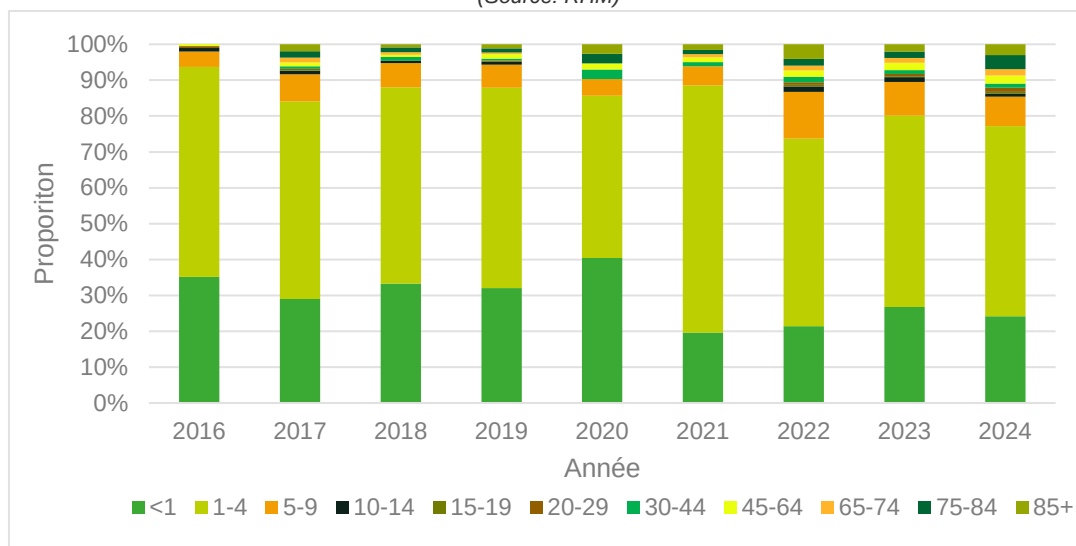
2.4.1. Hospitalisations

La grande majorité des hospitalisations pour une gastro-entérite causée par le rotavirus au cours des ans concerne des enfants de moins de 5 ans (Figure 8). En 2024, il y a eu 2039 hospitalisations pour des gastro-entérites causées par le rotavirus (Figure 1), dont 77% chez des enfants de moins de 5 ans (n=1574). Cela correspond à une incidence de 3 hospitalisations pour 1000 enfants de moins de 5 ans en Belgique.

Le groupe d'âge des 5-9 ans est également touché, mais dans une bien moindre mesure. Depuis 2022, on constate une augmentation surprenante du nombre d'hospitalisations dans ce groupe, probablement liée à une diminution de la circulation du rotavirus due aux mesures préventives mises en place pendant la pandémie de COVID-19, avec pour conséquence que le système immunitaire de ces enfants a reçu moins de boosters 'naturels'. En 2024, ce nombre semble de nouveau se normaliser et ce groupe représente 8% (n=168) de toutes les hospitalisations.

Chez les personnes de 75 ans et plus, un plus grand nombre d'hospitalisations a été rapporté en 2024 qu'en 2023. Il reste à voir si la forte augmentation du nombre de tests (PCR) positifs chez les personnes âgées en 2025 se traduira également par une croissance des hospitalisations pour des gastro-entérites causées par le rotavirus (données pas encore disponibles).

Figure 8: Nombre d'hospitalisations pour une gastro-entérite causée par le rotavirus, par groupe d'âge, 2016-2024
(Source: RHM)



2.4.2. Mortalité

Les décès attribués à une gastro-entérite causée par le rotavirus sont extrêmement rares. Dans la période 2019-2022, seulement 3 décès ont été signalés d'après les actes de décès collectés par Statbel. Ces décès concernaient tous des personnes de plus de 90 ans. Depuis 2008, la période post-vaccinale, plus aucun cas de décès n'a été signalé chez des enfants de moins de 5 ans.

3. Importance pour la santé publique

Le rotavirus provoque des gastro-entérites aiguës, caractérisées par des vomissements et de la diarrhée aqueuse. Dans le monde, la diarrhée reste une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans, et le rotavirus était responsable d'environ 120.000 décès en 2021, dont la majorité dans les pays à faible revenu (5). Bien que la mortalité suite à de la diarrhée soit extrêmement faible dans les pays à revenus élevés, la diarrhée y demeure toutefois une cause fréquente d'hospitalisation chez les jeunes enfants, généralement par suite d'une déshydratation.

Deux vaccins contre le rotavirus sont disponibles en Belgique, qui sont partiellement remboursés depuis novembre 2006 : le Rotarix® (monovalent, contenant le rotavirus humain de génotype G1P[8], administré à 8 et 12 semaines) et le RotaTeq® (pentavalent, contenant les génotypes humains G1, G2, G3, G4 et P[8], administré à 8, 12 et 16 semaines). Ces vaccins vivants atténués, administrés par voie orale, offrent une bonne protection contre les formes graves de gastro-entérite causée par le rotavirus (VE: 84-91%) (4). Depuis leur introduction en Belgique, l'épidémiologie du rotavirus a fortement changé, avec une diminution de 79 % des cas chez les enfants de moins de 2 ans et une baisse de 87 % des hospitalisations par rapport à la période pré-vaccinale (5). De plus, les vaccins ont également eu une influence sur la saison du rotavirus et sur la distribution des génotypes (6).

Malgré les avantages évidents de la vaccination, la couverture vaccinale en Belgique reste sous-optimale. On estime que 79.5% des enfants nés en 2022 sont entièrement vaccinés contre le rotavirus. De plus, il existe de grandes inégalités géographiques et socio-économiques (7). Un renforcement de la couverture vaccinale, en reprenant par exemple la vaccination dans les programmes de vaccination gratuite, pourrait atténuer ces inégalités et continuer à réduire la charge restante de la maladie.

En 2025, les nombres les plus élevés de cas rapportés ont été observés depuis l'introduction de la vaccination. L'augmentation se produit surtout chez les personnes de ≥ 80 ans et principalement en Flandre. Cette augmentation doit avant tout être mise en perspective avec les modifications importantes survenues dans les méthodes diagnostiques. L'introduction et l'utilisation en hausse des panels gastro-intestinaux par PCR multiplex a probablement conduit à une indication de test plus large et à une meilleure détection, surtout dans les groupes d'âge plus élevés, où les tests de rotavirus n'étaient pas souvent réalisés dans le passé, car les tests antigéniques ne sont pas remboursés par l'INAMI chez les patients âgés de plus de 2 ans. La surveillance s'est ainsi déplacée d'une approche principalement pédiatrique vers une population plus large, ce qui peut expliquer une grande partie de la hausse spécifique à l'âge. De plus, les tests PCR sont plus sensibles que les tests antigéniques, ce qui permet de détecter plus fréquemment les résultats faiblement positifs et les co-infections. Par conséquent, les chiffres de 2025 ne peuvent pas directement être comparés à ceux des années précédentes.

Bien que ce glissement dans le diagnostic explique probablement une partie importante de l'augmentation, une réelle hausse dans la circulation du virus ne peut pas être exclue. Des augmentations similaires sont rapportées au niveau international. Le Royaume-Uni a ainsi rapporté une hausse de 50% pour la saison 2024-2025 par rapport à la saison précédente (8), et une augmentation générale a également été constatée en Finlande, avec une hausse marquée dans les groupes d'âge plus élevés, sans qu'un changement dans les méthodes de test en soient à l'origine.

Pour la surveillance future, il est essentiel de collecter systématiquement des informations sur les indications des tests et sur les méthodes diagnostiques utilisées afin de pouvoir mieux standardiser les tendances. En outre, une surveillance épidémiologique et génotypique reste essentielle pour continuer d'évaluer l'impact des programmes de vaccination pour les jeunes enfants et pour détecter de nouveaux génotypes émergents et/ou une dérive antigénique des souches évitables par la vaccination.

Plus d'informations

- Informations sur la vaccination contre le rotavirus: [Conseil Supérieur de la Santé](#)
- Informations générales sur le rotavirus: [ECDC](#)
- Rapports épidémiologiques années précédentes: [Sciensano](#)
- Rapports et publications CNR: [CNR rotavirus](#)
- Réseau européen de surveillance du rotavirus: [EuroRotaNet](#)
- Couverture vaccinale dans le monde: [WHO](#)

Références

1. Rotavirus: Vaccine Preventable Diseases Surveillance Standards [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from: <https://www.who.int/>
2. Karataş M, Bloemen M, Cuypers L, Wollants E, Van Ranst M, Matthijnssens J. 14 years of rotavirus A surveillance: unusual dominance of equine-like G3P[8] genotype with DS-1-like genotype constellation after the pandemic, Belgium, 2009 to 2023. *Eurosurveillance*. 2025 Mar 27;30(12):2400442.
3. GBD 2021 Diarrhoeal Diseases Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific burden of diarrhoeal diseases, their risk factors, and aetiologies, 1990-2021, for 204 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Infect Dis*. 2025 May;25(5):519-536. doi: 10.1016/S1473-3099(24)00691-1. Epub 2024 Dec 18. PMID: 39708822; PMCID: PMC12018300.
4. Hoge Gezondheidsraad [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Rotavirus. Available from: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/8812/rotavirus>
5. Sabbe M, Berger N, Blommaert A, Ogunjimi B, Grammens T, Callens M, et al. Sustained low rotavirus activity and hospitalisation rates in the post-vaccination era in Belgium, 2007 to 2014. *Eurosurveillance*. 2016 Jul 7;21(27):30273.
6. Zeller M, Rahman M, Heylen E, De Coster S, De Vos S, Arijs I, et al. Rotavirus incidence and genotype distribution before and after national rotavirus vaccine introduction in Belgium. *Vaccine*. 2010 Nov 3;28(47):7507-13.
7. Dambre C, Rousseau R, Hansford K, Cornelissen L. Rotavirus vaccination in Belgium : trends and inequalities. [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from : <https://www.sciensano.be/nl/biblio/rotavirusvaccinatie-belgie-trends-en-ongelijkheden>
8. UK Health Security Agency. National norovirus and rotavirus report, week 28 report: data to week 26 (data up to 29 June 2025). [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from: <https://www.gov.uk/government/statistics/national-norovirus-and-rotavirus-surveillance-reports-2024-to-2025-season/national-norovirus-and-rotavirus-report-week-28-report-data-to-week-26-data-up-to-29-june-2025#contents>

Ce projet est soutenu financièrement par:



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu



Wallonie
familles santé handicap
AVIQ



CONTACT

Surveillance épidémiologique des maladies infectieuses évitables par la vaccination:
vpd@sciensano.be

Personne de contact épidémiologie du rotavirus: cato.dambre@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Sciensano.be – info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11